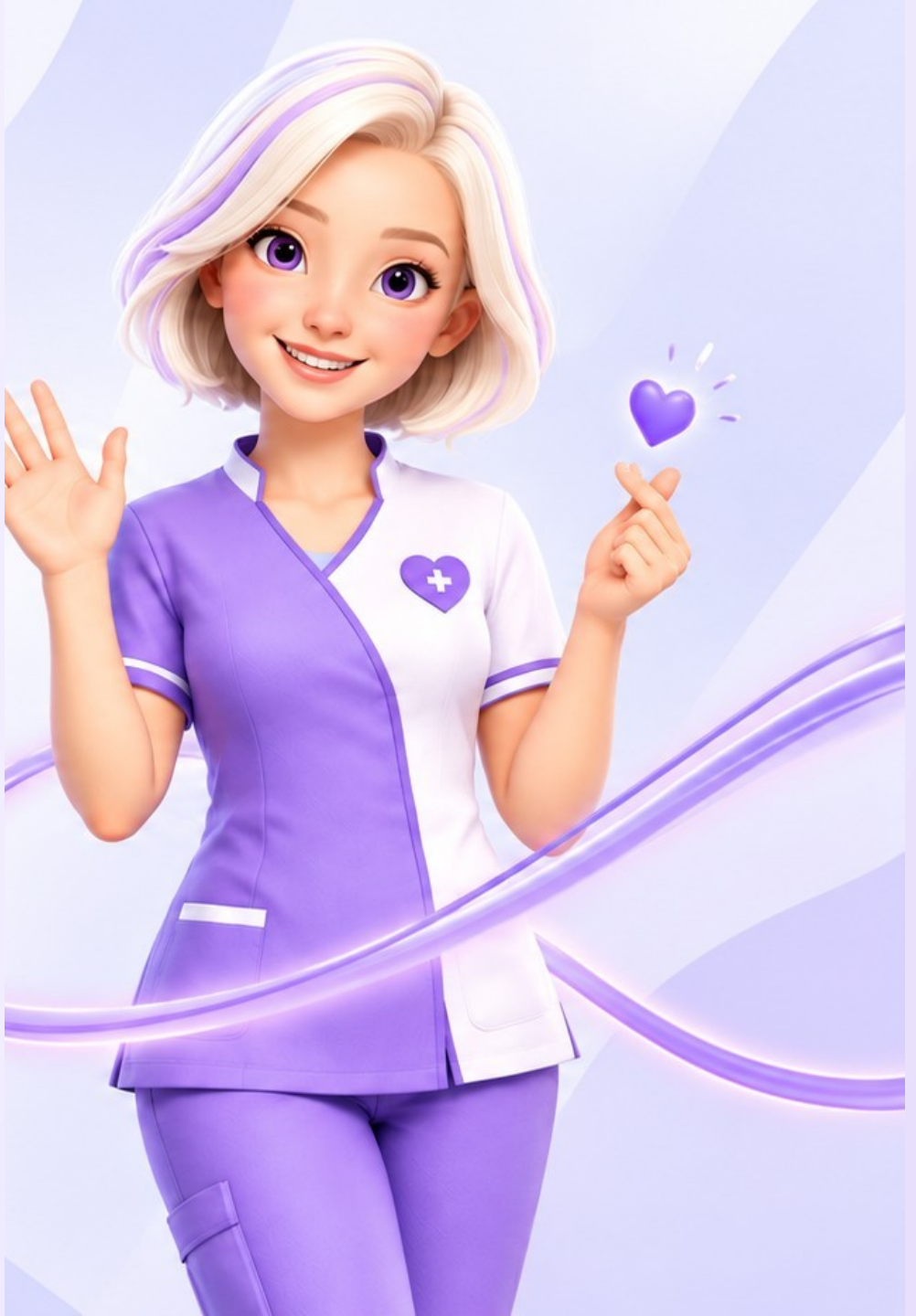
FIAP NEXT 2026

DaisyCare

Consulta cancelada não é perdida.
É vaga para outro paciente.

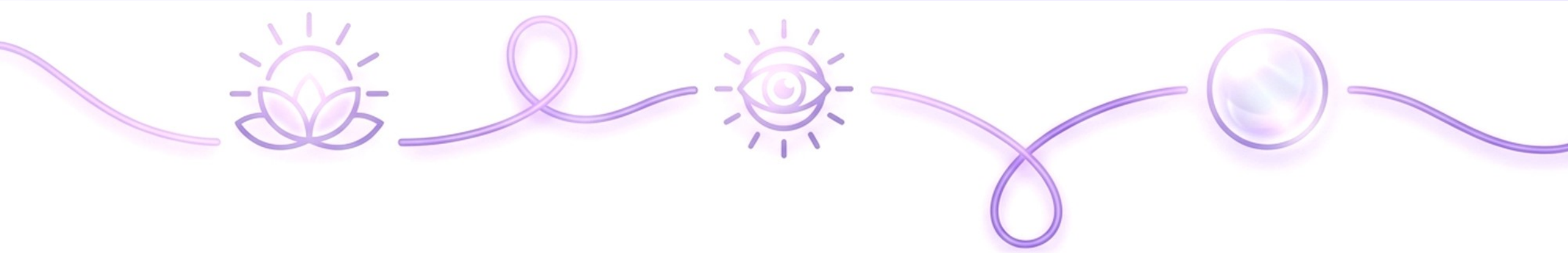
Assistente virtual no app e no WhatsApp que confirma, encaixa e orienta o paciente, com 16 workflows rastreados do canal ao Power BI.



DAISYCARE · A ORIGEM DO NOME

Por que “Daisy”?

Um nome que já conta a história da nossa operação.



Olho do dia

Day’s eye: a flor que se abre com a luz da manhã.

VER

Dar visibilidade à jornada antes que um evento vire exceção.

Olho do sol

Solis oculus, em latim.

ORIENTAR

Guiar o paciente com linguagem simples: rota, fila, preparo e próximos passos.

Pérola

Margarita, do grego *margarítēs*.

VALORIZAR

Tratar cada horário, a experiência e os dados como ativos que não podem ser desperdiçados.

1 em cada 12 pacientes falta à consulta, e a taxa não melhorou em 12 meses

8,7%

das consultas termina com a cadeira vazia

16,8 mil

faltas em 200 mil agendamentos

27 mil

vagas vazias, somando faltas e cancelamentos

Fonte: base operacional DaisyCare, 200 mil agendamentos em 10 hospitais, set/2025–ago/2026.

O hospital só descobre a falta na hora da consulta, e outro paciente perde a vez

PARA QUEM

Hospitais e clínicas

Vaga vazia vira receita perdida e agenda ociosa

Pacientes

Ficam sem horário enquanto a vaga de quem faltou fica vazia

O CONTEXTO EM NÚMEROS

28%

dos pacientes não confirmam a consulta 24 h antes

12% vs 7%

de faltas entre quem não confirma e quem confirma

10 hospitais

em 5 estados, com 200 mil pacientes

Fonte: base operacional DaisyCare, 200 mil agendamentos em 10 hospitais, set/2025–ago/2026.

O INTERVALO ENTRE MARCAR E ATENDER

Sete falhas se somam, e ninguém acompanha esse intervalo de forma ativa

01

Faltas sem aviso

O esquecimento é o motivo mais comum

02

Vaga sem reocupar

Cancelamento de última hora vira horário ocioso

03

Médico atrasado

O paciente só descobre quando chega

04

Espera às cegas

Sem posição na fila nem tempo previsto

05

Central lotada

Confirmar e remarcar por telefone tomam o dia

06

Cobrança lenta

Fila no caixa e envio manual, sem validar quem paga

07

Dados soltos

CRM, WhatsApp, agenda e financeiro sem o mesmo identificador: a gestão não mede no-show nem receita perdida

A Daisy confirma, encaixa e orienta o paciente, sem tomar decisão clínica

Confirma

Lembra 24 h, 16 h, 4 h e 2 h antes e registra a resposta

Encaixa

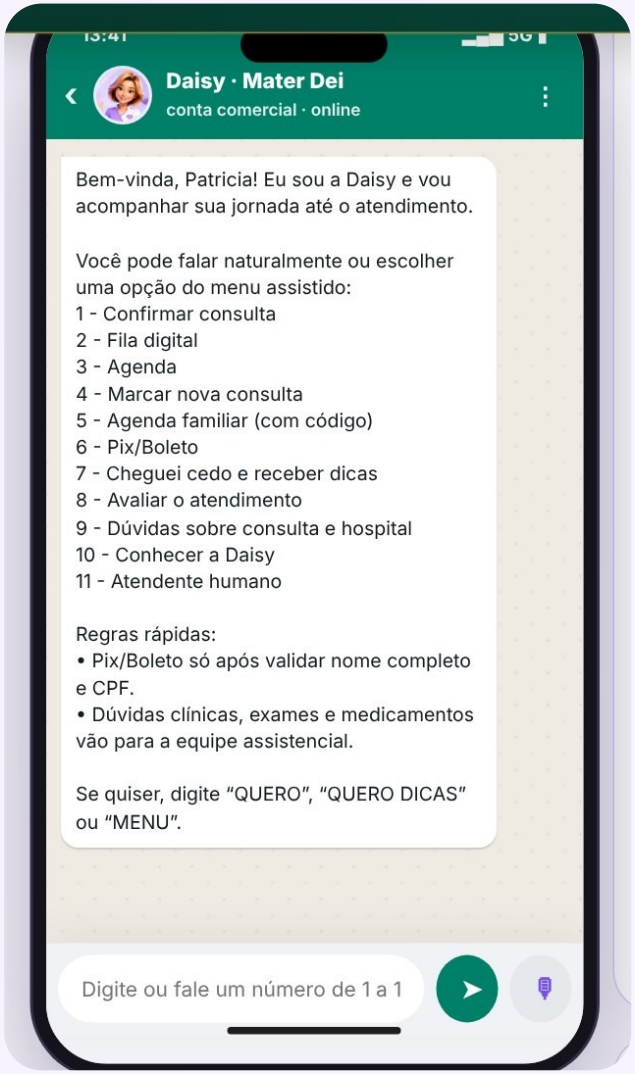
Oferece a vaga cancelada a quem chega a tempo

Orienta

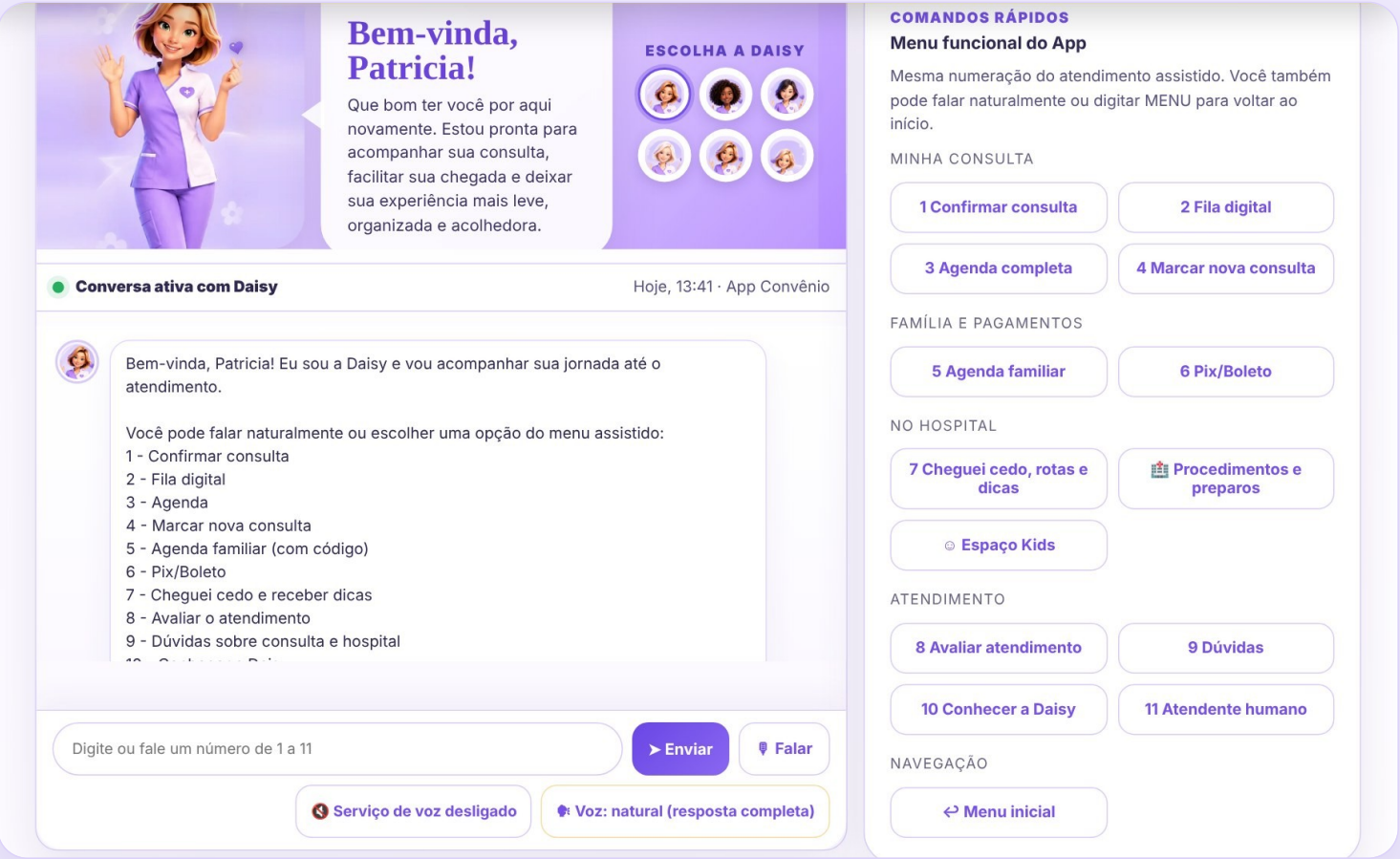
Envia preparo, jejum e a melhor rota até o hospital

Confirmar reduz o *no-show* em **30% a 65%**, conforme o encadeamento das mensagens. Fonte: UTech.

O que ela não faz: diagnóstico, receita ou leitura de exames. Qualquer risco clínico vai direto para a equipe humana.



O mesmo atendimento no app e no WhatsApp, por texto ou por voz



11

opções no menu, com a mesma numeração nos dois canais

Voz natural

a Daisy lê datas, horários e especialidades

Nome + CPF

antes de qualquer Pix, boleto ou nova consulta

Opção 11

atendente humano, com resumo da conversa

O MVP já acompanhou 200 mil agendamentos em 10 hospitais

COMO O MVP FUNCIONA

WhatsApp e app
onde o paciente conversa

→

Automação
16 workflows no n8n

→

IA de risco
aponta quem pode faltar

→

Painel do gestor
resultados no Power BI

200 mil
agendamentos acompanhados em 12 meses

72%
dos pacientes confirmaram a consulta 24 h antes

60%
das confirmações chegaram pelo WhatsApp

Fonte: base operacional DaisyCare, 200 mil agendamentos em 10 hospitais, set/2025–ago/2026.

DEMONSTRAÇÃO

Do cancelamento ao encaixe em 3 passos

1

A paciente cancela

Responde no WhatsApp que não vai. Vagas liberadas até 2 h antes vão para a Smart Queue.

Na tela: conversa no WhatsApp

2

A Daisy oferece a vaga

Cruza a fila de espera com o tempo de deslocamento e envia o convite.

Na tela: fila da Smart Queue

3

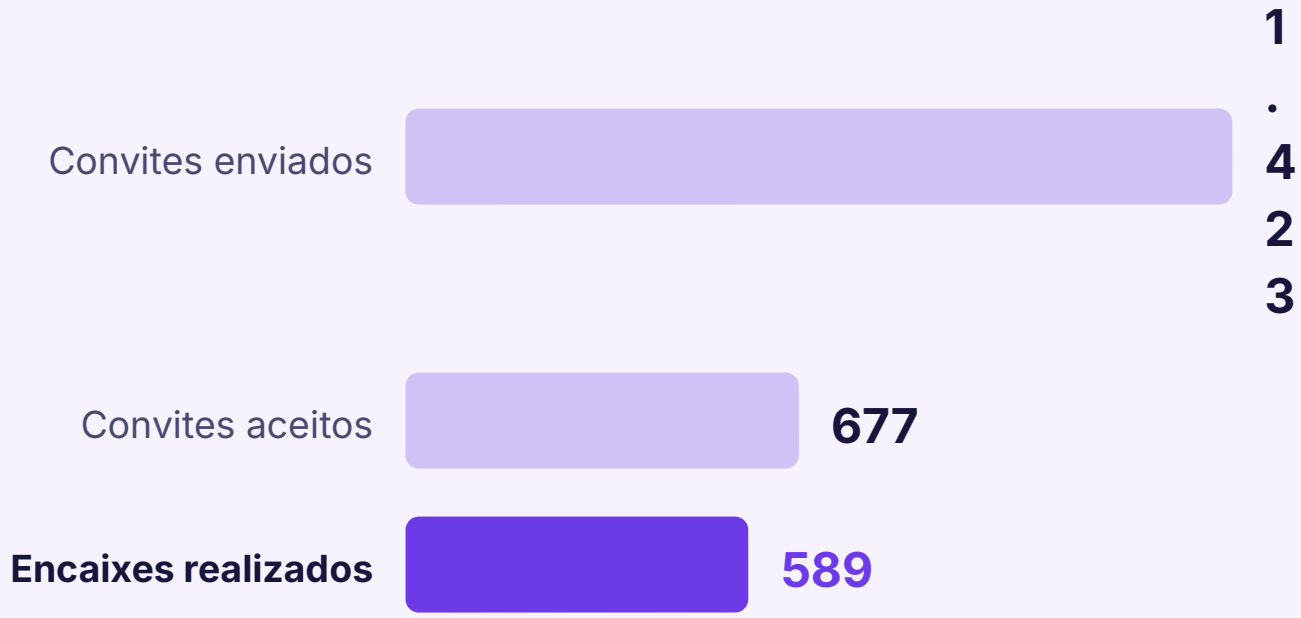
Outro paciente aceita

O encaixe é confirmado e o gestor vê a vaga recuperada no painel.

Na tela: painel no Power BI

589 vagas que ficariam vazias viraram consultas

Encaixes pela fila inteligente, set/2025–ago/2026



48%

dos convidados aceitam o encaixe

87%

dos aceites viram consulta realizada

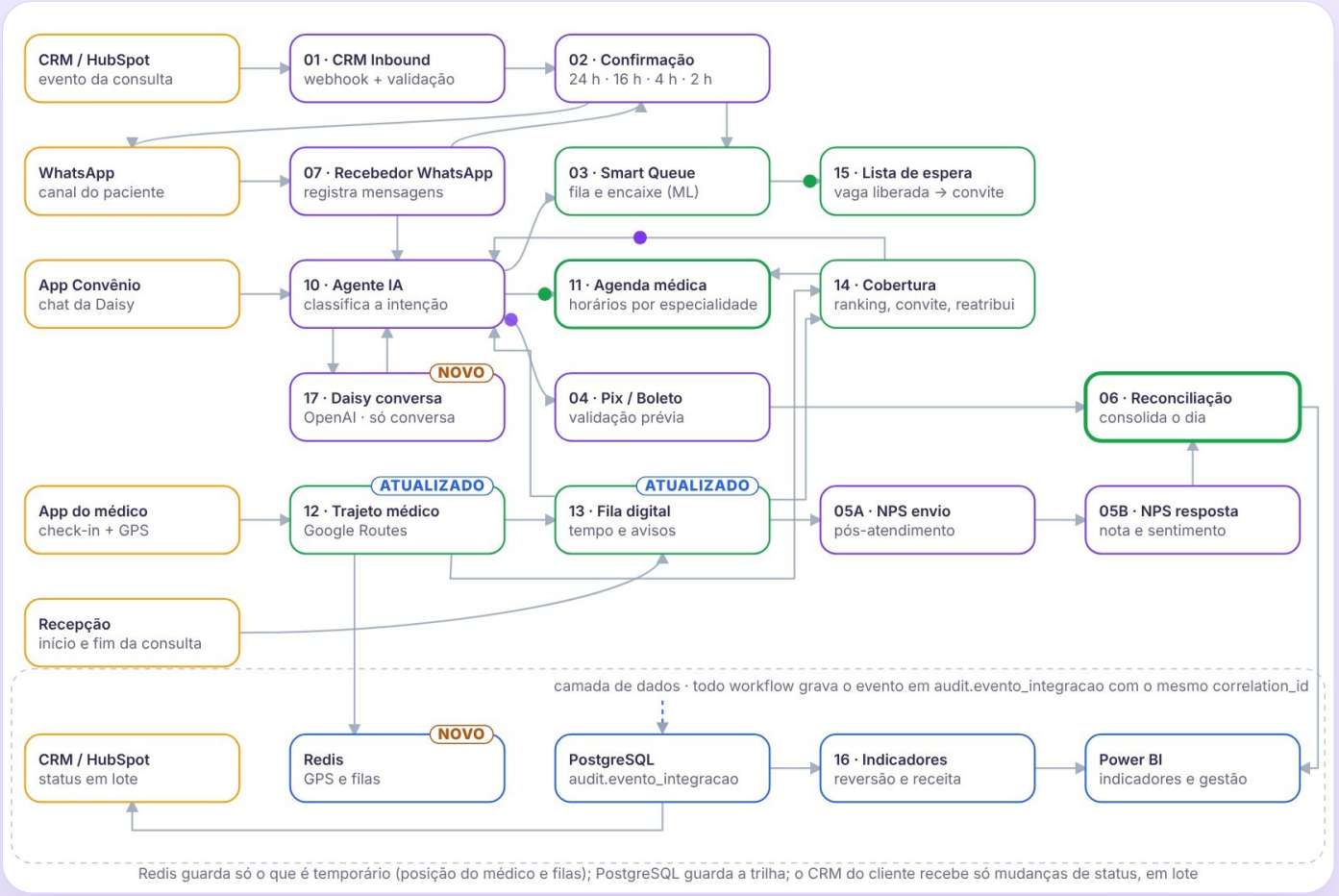
2,8 mil[1]

faltas a menos por ano se todos confirmarem

1. Estimativa: 55,9 mil pacientes sem confirmação × 5 pontos a menos de falta (12% para 7%). Fonte: base operacional DaisyCare, 200 mil agendamentos.

COMO FUNCIONA

16 workflows n8n ligam cada falha a um indicador



Uma trilha só

Todo evento grava o mesmo correlation_id, do canal ao Power BI

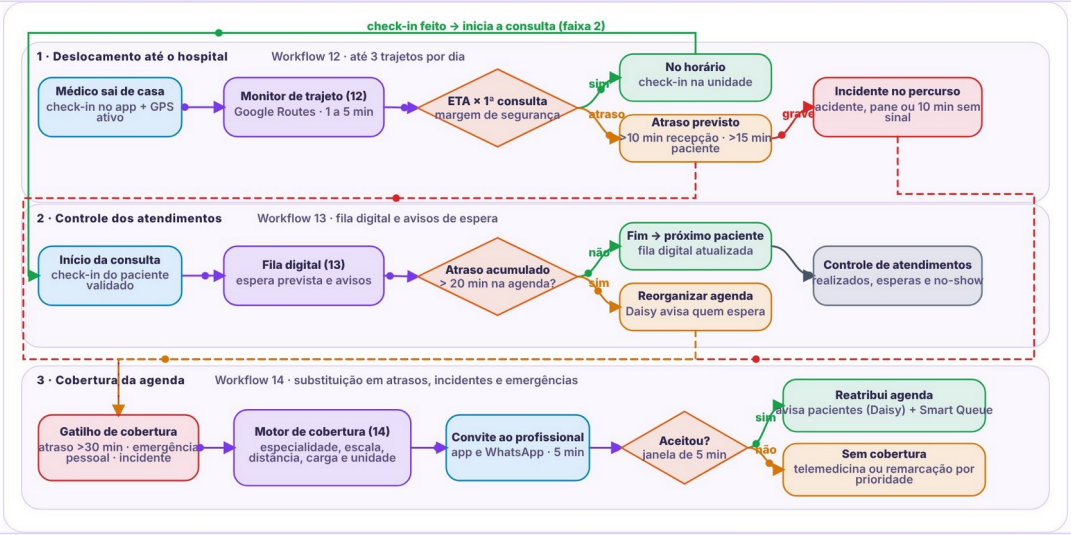
Novo: 17 · Daisy conversa

Dúvidas gerais e histórias com OpenAI, sem acesso a agenda, Pix ou CRM

Dados por papel

Redis no tempo real, PostgreSQL na trilha, CRM do cliente com status em lote

O atraso do médico vira aviso, não surpresa na recepção



12 · Trajeto

ETA no Google Routes a cada 1 a 5 min, até 3 trajetos por dia

13 · Fila digital

Espera prevista pela mediana do médico; aviso se mudar 10 min

14 · Cobertura

Acima de 30 min ou incidente: ranking e convite com 5 min

Evolução controlada: Bronze valida a ideia, Prata opera o fluxo, Ouro escala

BRONZE · PROVA DE CONCEITO

Validar a ideia

Offline, arquivos locais e demonstração acadêmica.

Por quê: testar a jornada sem custo nem risco.

PRATA · MVP, HOJE

Operar o fluxo

n8n self-hosted, webhooks, PostgreSQL, Power BI e voz gravada da Daisy.

Por quê: tecnologia aberta, barata e legível pela TI do hospital; vira Ouro sem reescrever os fluxos.

OURO · PRODUÇÃO

Escalar com segurança

Azure (API Management, Entra ID, Key Vault), CRM do hospital, Redis, WhatsApp Business, Google Routes, OpenAI e AI Speech.

Por quê: dados reais, porta única com OAuth 2.0, segredos fora do código e serviços gerenciados.

No Ouro, tudo entra por uma porta única e cada dado fica no lugar do seu papel

Canais	App da Daisy	WhatsApp Business	App do médico	
Entrada	**Azure API Management · porta única com OAuth 2.0, WAF e limites de uso**			
Lógica	API DaisyCare · chat, agenda, fila e voz		n8n · workflows 01 a 17	
Serviços	Azure AI Speech	OpenAI (17)	Google Routes (12)	Doc Intelligence
Dados	CRM do hospital · status	PostgreSQL · eventos	Redis · tempo real	Service Bus
Governança	Entra ID	Key Vault	App Insights	Power BI

500 mil operações por mês são 0,2 por segundo em média: a divisão entre CRM, PostgreSQL e Redis é por papel, não por capacidade.

O limite clínico: o que a Daisy faz e o que ela não faz

ZONA OPERACIONAL · A DAISY FAZ

- Lembretes e confirmação de agenda
- Posição na fila digital e Smart Queue
- Preparo e jejum já cadastrados pelo hospital
- Pix e boleto após validar nome e CPF

FRONTEIRA · VAI PARA UM HUMANO

- Interpretar laudos e exames
- Alterar ou suspender medicamentos
- Avaliar sintomas ou diagnosticar
- Urgência: orienta pronto-socorro ou 192

LGPD: CPF, e-mail e telefone mascarados; nenhum dado clínico em log

GPS do médico: só com consentimento, apagado em até 6 h

Auditoria: 34 regras e todo evento com correlation_id

Como provamos o valor: três contas simples, medidas desde o primeiro dia

Taxa de no-show	faltas ÷ agendamentos	**8,7% hoje**
Eficiência do encaixe	convites aceitos ÷ convites enviados	**48%**
Receita preservada	vagas reaproveitadas × ticket médio	**vale para cada encaixe**

R$ 147 mil

por ano com os 589 encaixes realizados

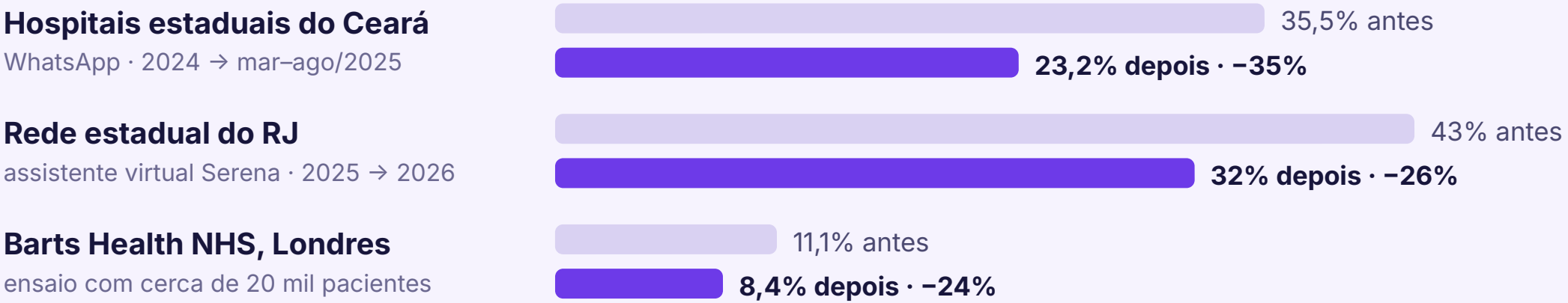
R$ 700 mil

por ano se as 2,8 mil faltas forem evitadas

Ticket médio ilustrativo de R$ 250 por consulta; trocar pelo valor real do hospital parceiro. Base: 200 mil agendamentos, set/2025–ago/2026.

Fora da DaisyCare, lembrete ativo derrubou as faltas em todos os casos

Taxa de faltas antes e depois; a DaisyCare soma a isso o encaixe, a cobertura e a fila digital



Revisão Cochrane, 8 ensaios e 6.615 pessoas: comparecimento de 78,6% com mensagem no celular, contra 67,8% sem lembrete.

Fontes: O Povo com dados da Sesa-CE (dez/2025); Correio da Manhã (jun/2026); Behavioural Insights Team/GOV.UK; Cochrane CD007458.

INDICADORES DE MERCADO

Três países, redes públicas e revisões científicas mostram a mesma alavanca

comunicação digital + agenda viva + decisão automatizada

23%

no-show médio no mundo

Revisão de 105 estudos · Dantas et al., 2018

+14%

mais chance de comparecer com mensagem no celular

Cochrane · 8 ensaios, 6.615 pessoas

−17% a −28%

de faltas em hospitais com plataforma de lembrete

Guy's and St Thomas' (Londres) e Gulfport (EUA)

43% → 32%

de faltas na rede estadual do RJ com assistente virtual

Correio da Manhã, jun/2026

12 fontes abertas, conferidas em 14/10/2026. Valores de casos diferentes não são somados.

REINO UNIDO E ESTADOS UNIDOS

Lá fora, lembrete e lista de espera já pagam a conta

11,1% → 8,4%	**Barts Health NHS · Londres** ensaio com ~20 mil pacientes, 2013–14	faltas com lembrete que cita o custo Behavioural Insights Team / GOV.UK
5,5 mi	**NHS England** ambulatórios, 2012–13	consultas perdidas em um ano (9,3%) Warwick Business School
–17,2%	**Guy's and St Thomas' NHS** Londres, 1º ano a partir de abr/2016	faltas; benefício de £ 2,6 mi no 1º ano DrDoctor
–28%	**Memorial Hospital at Gulfport** EUA · Mississippi, 7 meses	no-show; ~US$ 804 mil em 7 meses Health Catalyst
–20%	**Mile Bluff Medical Center** EUA · Wisconsin, 7 meses	no-show; US$ 200 mil a mais por ano Luma Health
US$ 1,2 mi	**Houston ENT & Allergy** EUA · Texas	receita extra com lista de espera inteligente Luma Health

Casos de fornecedores (DrDoctor, Health Catalyst, Luma Health) são resultados divulgados pelas próprias empresas.

BRASIL E ESTUDOS CIENTÍFICOS

No Brasil, a falta é grande e o WhatsApp já funciona

35,5% → 23,2%	**Hospitais estaduais do Ceará** WhatsApp, 2024 → mar–ago/2025	faltas a consultas e cirurgias O Povo, com dados da Sesa-CE
43% → 32%	**Rede estadual do RJ · Serena** assistente virtual, 2025 → jun/2026	faltas em consultas e exames Correio da Manhã e CONASS
≈ 13%	**Porto Alegre · especialidades** 2025	consultas perdidas: 45.607 no ano Prefeitura de Porto Alegre
≈ 30%	**Ribeirão Preto · atenção primária** 2020–21	absenteísmo em consultas agendadas Interface (Botucatu), 2023
23%	**Revisão de 105 estudos** mundo, publicados até 2017	no-show médio; África 43%, Oceania 13% Dantas et al., Health Policy, 2018
+14%	**Cochrane · mensagem no celular** 8 ensaios, 6.615 pessoas	mais comparecimento (78,6% contra 67,8%) Cochrane CD007458

Referências de setor, imprensa e estudos; não são auditorias. Trocar pelos números reais do hospital parceiro assim que o piloto rodar.

Próximos passos: implantar sem “virar a chave” de uma vez

2–4 semanas

Descoberta

Mapear a agenda, os sistemas e as regras do hospital parceiro

4–8 semanas

Piloto

Daisy em uma unidade, escopo controlado, no-show e NPS medidos por 90 dias

6–12 semanas

Integração

APIs oficiais, login corporativo, segredos e monitoramento

Contínuo

Escala

Mais unidades e especialidades, com observabilidade

Consulta cancelada não é perdida. É vaga para outro paciente.



Tecnologia em saúde não precisa ser fria.

Com automação, dados estruturados e empatia, a DaisyCare organiza a jornada para que a operação tenha previsibilidade e o paciente receba o cuidado na hora certa.

Obrigado.

PARA AS PERGUNTAS DA BANCA

Apêndice

IA preditiva, dados e escala, contingência

IA preditiva onde faz sentido, e apenas onde faz

Base treinada

~200 mil

agendamentos

AUC

0,708

F1-score

0,702

Apoio, não substituição

O modelo não decide quem vai faltar: ordena o risco para priorizar o contato preventivo

Soberania humana

Limites e prioridades calibrados com o hospital; a decisão assistencial continua humana

Explicabilidade

Desempenho e desvio monitorados, sem automatizar decisões clínicas às cegas

Mantemos o CRM do cliente: cada banco tem um papel, não uma cópia

Onde	O que guarda	Quem grava	Quem lê
CRM do cliente	Cadastro e status atual do paciente	Só mudanças de status, em lote	Atendimento e marketing
PostgreSQL	Trilha de eventos (audit.evento_integracao)	Todos os workflows, mesmo correlation_id	Power BI e auditoria
Redis	GPS do médico (6 h) e filas (16 h)	Workflows 12 e 13	Os próprios workflows

500 mil
operações por mês

≈17 mil
por dia

0,2/s
em média; cabe num banco só

Quem faz o quê, e o que acontece se algo falhar

Produto e visão

Define a jornada humanizada e as regras de comunicação da Daisy

TI, Dados e Ops

Sustenta a infraestrutura Azure, as integrações oficiais e a calibração de prioridades

Se o sistema falhar: resiliência

Backups, logs redundantes no PostgreSQL, Service Bus segurando eventos e job noturno que reprocessa webhook perdido

Se a jornada falhar: fallback

API fora ou dado inválido: menu seguro, recomeço do fluxo ou alerta direto à equipe. O paciente nunca fica sem resposta